四、治疗“激素怎么补,看肾上腺怎么切”

1.库欣病 不用开颅 肿瘤停止分泌ACTH后 ACTH短期内骤降,GC也骤降

①首选**经蝶窦切除肿瘤+短期补激素** 等垂体又再自己产激素,轴恢复正常为止

②手术失败或术后复发→垂体放疗

③上述失败→**切除双侧肾上腺+终身补激素**。由于术后存在发生 **Nelson** 综合征（皮肤色素加深、原有垂体瘤增大）的危险，应监测垂体 MRI 和血 ACTH

切后GC↓→ACTH↑↑

2.肾上腺皮质瘤或癌

①若为**单**侧：**切除患侧肾上腺+较长期补激素（半年-1 年或更久）**

②若肾上腺皮质癌已转移：肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑（酮糖绝交）

失去手术机会

生化:糖不能变成酮体,酮体也不能异生为糖

3.不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小/大结节性增生：**切除双侧肾上腺+终身补激素**

真题解析·库欣综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N108-110 A 男性，46 岁。有乏力、腰背痛 2 年，常有便秘，既往高血压病史 5 年。查体：腹部稍膨隆，四肢近端较细，胸椎 X 线提示有骨质疏松，B 超显示左侧肾上腺可见一直径约 3.5cm 的肿物，临床拟诊为“皮质醇增多症”。

108.以上描述中，对提示“皮质醇增多症”诊断意义不大的是

A.腹部膨隆 脂肪重新向心性分布

B.高血压 最早的表现

C.便秘 甲减、嗜铬细胞瘤

D.骨质疏松 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收

109.为进一步明确“皮质醇增多症”诊断，最有价值的检查是

小征大病

A.肾上腺 CT

B.小剂量地塞米松抑制试验

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.血 ACTH

110.患者确诊为“肾上腺腺瘤”，以下治疗原则中正确的是

A.单纯手术切除腺瘤

B.手术切除+短期激素替代治疗

C.手术切除+较长期激素替代治疗 单侧

D.手术切除+终身激素替代治疗

2.2020N159 X Cushing 综合征可出现的临床表现有

A.贫血 RBC、Plt、中性粒细胞↑减少酸雨降临

B.病理性骨折

C.精神异常

D.皮肤色素沉着 ACTH-促黑素

以题带动 知识点复习

答案：1-2 CBC BCD